

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	子宮早期收縮 Premature Uterine Contraction				
編號	A31000-Q03-W-M10	制定者	R9 黃麗華	公布日期	102 年 04 月 26 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 09 月 06 日
版本/總頁數	第 1.5 版/8 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員能了解並正確執行子宮早期收縮個案照護。

二、範圍

婦產科單位。

三、說明

（一）定義

妊娠週數 20-37 週，子宮出現每 10 分鐘（或更少）有一次收縮，每次持續 30 秒以上之情形，則醫師會建議入院安胎治療。

（二）症狀

腹部疼痛、背痛、骨盆疼痛、像月經來時的絞痛、陰道分泌物增多（可能是帶粉紅色或黏液狀的性質）、骨盆壓力、頻尿、腹瀉等。

（三）常見檢查

裝胎兒監測器監測子宮收縮頻率及壓力、羊水試紙測試破水情形。

（四）常見治療

1. 非藥物治療：臥床休息。
2. 藥物治療： β 交感神經作用劑、催產素抑制劑、平滑肌鬆弛劑、鈣離子阻斷劑、硫酸鎂等。

（五）護理問題

1. 易受傷害／與迫切性早產有關。

主題名稱	子宮早期收縮	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	2/8

2. 焦慮感受／1.與無預期入院安胎及住院壓力有關；2.與面臨安胎及胎兒情況不穩定有關。
3. 舒適感受改變／與安胎藥物副作用、及長期臥床有關。
4. 家庭運作過程不一致／與長期住院安胎及缺乏家庭支援有關。
5. 失去因應能力／與長期安胎及失去控制力有關。
6. 睡眠障礙／與住院陌生環境及宮縮不適有關。

(六) 護理措施

1. 易受傷害／與迫切性早產有關

- (1) 指導個案早產徵兆的觀察，並給予護理指導單張，如陰道出血、分泌物增加、子宮收縮的觀察、持續下背痛、破水等。
- (2) 指導個案目前使用安胎藥物之必要性在抑制子宮收縮避免早產徵象的出現及早產的發生。
- (3) 指導安胎藥物作用、副作用，如 Ritodrine 會使子宮平滑肌鬆弛抑制宮縮、副作用為心悸、噁心嘔吐。
- (4) 指導個案臥床休息可增加子宮血液灌流、減少刺激。
- (5) 指導個案臥床休息目的在避免早產的發生，並給床旁便盆椅使用減少活動。
- (6) 指導個案每日 2-3 次採側臥及半坐臥姿勢以增加胎盤血流。
- (7) 指導個案當有自我觀察到密集宮縮或陰道有出血、分泌物增加須立即通知護理人員。
- (8) 每日行胎心音之監測、當發現宮縮頻繁時協助給予放置胎兒監視器監測及依醫囑調整安胎藥物。
- (9) 每日胎心音之測量及妊娠 28 週後每週給予 NST 的監測，並說明結果。
- (10) 配合醫療措施每週至兩週一次的超音波檢查，注意子宮頸是否有變短情形。

主題名稱	子宮早期收縮	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	3/8

2. 焦慮感受／1.與無預期入院安胎及住院壓力有關；2.與面臨安胎及胎兒情況不穩定有關

- (1) 評估個案焦慮程度及主要原因。
- (2) 請醫師解釋疾病目前狀況與對胎兒的影響。
- (3) 胎兒監視器監測時，隨時注意並主動告知子宮收縮頻率與強度及胎心音正常數據。
- (4) 隨時觀察病患有無早產之跡象：如陰道出血、破水、宮縮。
- (5) 若已破水，教導臀部抬高以減少羊水流出情形。
- (6) 必要時安排會診早產兒加護病房醫療團隊介入，告知早產兒之合併症與相關照護，以減少對未知的恐懼與焦慮。
- (7) 陪伴個案每週定期的超音波檢查，檢查後由醫師解釋胎兒發育狀況，使其更有能力自我監測母胎之狀況與胎兒具體化的心理適應，以減輕焦慮不安。
- (8) 常予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。

3. 舒適感受改變／與安胎藥物副作用、及長期臥床有關

- (1) 觀察安胎藥物 Ritodrine 及 MgSO₄ 藥物副作用造成不適之情形。
- (2) 監測生命徵象變化，注意有無心悸、呼吸喘、血氧濃度、熱潮紅等情形。
- (3) 指導個案有不適症狀時通知護理人員，當主訴呼吸不順時，協助採半坐臥並依醫囑給予鼻導管氧氣 3L/min 使用。
- (4) 主訴有熱潮紅時，協助調整室內溫度維持在 25-26 度或調整被蓋。
- (5) 指導臥床安胎並不是完全平躺，鼓勵採側臥或半坐臥；可在床上翻身及執行肢體關節活動。
- (6) 指導並協助個案利用枕頭或 L 型枕可墊於腰部支撐及改變姿勢之支撐。
- (7) 教導家屬協助予個案腰部局部輕柔按壓，以減輕腰痠不適並回覆示教。
- (8) 指導睡前足部泡浴，減輕不適及促進睡眠。
- (9) 持續追蹤舒適型態是否改變。

主題名稱	子宮早期收縮	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	4/8

4. 家庭運作過程不一致／與長期住院安胎及缺乏家庭支援有關

- (1) 與個案建立良好的治療關係，鼓勵說出心中感覺並傾聽對於安胎感受。
- (2) 鼓勵個案表達住院安胎感受，加強彼此情感的凝聚力。
- (3) 陪同醫師與夫妻共同討論解釋安胎處置及未來治療方向。
- (4) 評估個案家庭的支持系統及社會支持系統。
- (5) 與家屬共同討論並計畫時間之分配，讓案夫能回家得到充分休息。
- (6) 安排病房病服員協助白天日常生活。
- (7) 安排同性質且有成功經驗者同室及分享住院安胎婦女及配偶之經驗。

5. 失去因應能力／與長期安胎及失去控制力有關

- (1) 與個案建立良好的治療性人際關係，以增進信任感。
- (2) 依據個案妊娠之週數，提供個別性床邊孕期指導，並以螢光筆加註重點，以利個案對孕期之了解。
- (3) 提供發洩情緒之管道，如聽音樂、雜誌與電視借閱、運用網路與外界聯繫等，以減輕心理不適之感受。
- (4) 提供增加自我控制感的方法，如教導常使用之物品放置隨手可得處、鼓勵使用臉盆裝水自行刷牙洗臉、如廁後自行擦拭與沖洗、視皮膚情形鼓勵自行擦拭乳液與共同設計生活作息表等。
- (5) 鼓勵家屬前來陪伴參與照護，協助執行自我控制力的方法。
- (6) 設計安胎日誌，教導標註妊娠時間與黏貼超音波照，並記錄當下的心情點滴，透過文字的表達，傳達胎兒的親密互動，以提供個案紓解壓力之管道，使其安胎過程充滿愛與希望。
- (7) 與個案共同訂定妊娠週數之目標，針對週數之進步，給予口頭上之稱讚與小卡片實質之鼓勵。
- (8) 給予適時關懷，傾聽與陪伴。
- (9) 鼓勵個案分享內心的想法，說出對安胎未來的期望，當個案表達負面想法時，輕拍肩膀以穩定情緒。

主題名稱	子宮早期收縮	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	5/8

(10) 鼓勵個案積極面對未來，保持穩定的情緒才能順利度過難關。

(11) 鼓勵家屬前來陪伴參與照護，共同營造一個支持環境，教導家屬善用親情力量，適當的肢體接觸，擁抱等非語言表達，以激勵個案的希望。

(12) 安排安胎成功的產婦回診時與個案分享心情點滴與加油打氣。

6. 睡眠障礙／與住院陌生環境及宮縮不適有關

(1) 評估個案過去與現在的睡眠與活動型態，以及目前懷孕對夜眠的影響。

(2) 與個案及家屬討論可能干擾的睡眠原因，包括安胎藥物對睡眠的影響。

(3) 與個案討論可以促進睡眠方法如聽音樂、喝溫熱食物、按摩與姿位改變等放鬆措施與促進睡眠的方法。

(4) 安排白天活動包括看電視與護理人員或家屬聊天，給予衛教手冊閱讀以增加個案白天活動量。

(5) 夜間採集中護理，以減少環境的刺激，並安排適當環境包括夜裡開小燈、房門關起。

(6) 白天活動盡可能於晚上 11 點完成即準備就寢，必要時夜間休息可使用耳塞。

(七) 衛教指導

1. 盡量臥床休息，可促進子宮胎盤間血液灌注量，減少刺激子宮頸變軟、變薄和擴張，延長胎兒在母體時間，增加胎兒成熟度避免早產。

2. 臥床易造成腹脹、腸蠕動下降，飲食建議採少量多餐，減少攝取產氣性食物與多攝取蔬果高纖維之飲食。

3. 避免排便型態改變，建議勿忽視便意感。

4. 使用安胎藥物後會造成心跳及呼吸加快、面潮紅、發抖等，若感心悸、呼吸很喘或不適要告知護理人員。

5. 每週會安排超音波評估胎兒體重及成長情形。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	子宮早期收縮	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	6/8

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲
(2020)．產科護理學（十版）．台北：新文京。
- (二) 涂儷燕、李秀蘭、施妙芳(2022)．住院安胎婦女焦慮及其預測因子．*長庚護理*，
33(1)，1-14。
- (三) 林莉莉、蔡玉梅、廖淑敏(2020)．照顧一位早期破水產婦安胎失敗之護理經驗．
馬偕護理雜誌，14(2)，69-80。

七、附件

(略)

主題名稱	子宮早期收縮	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M10	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.04.26	1.0	新制定	102 年 04 月 26 日護理部照護標準委員會通過；102 年 04 月 26 日公布
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	1.1	新增第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	1.2	1.將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第三項第（四）、（五）、（六）、（七）目內容刪修。 3.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	1.3	1. 第三項第（二）、（五）、（六）目內容部份增刪。 2. 更新第六項文獻參考資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.02.14	1.4	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日照護標準組會議通過；108 年 3 月 13 日護理長會議通過；108 年 3 月 18 日督導會議通過公布
109.08.06	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	1.5	1. 第三項第五、六目之護理問題名稱修訂。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 刪除內文參考文獻。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。

